

Síndrome nefrótica · edema e proteinúria

Nefrótico = proteinúria maciça + hipoalbuminemia + edema ($\pm$ hiperlipidemia). Trate edema e impeça complicações; a biópsia define etiologia no adulto.

Causas por faixa

Dica - Causas por faixa

Criança: lesões mínimas. Adulto: membranosa, FSGS, amiloidose, diabetes. Sempre rastrear HBV/HCV/HIV, LES e neoplasias quando indicado.

Fórmula mental de prova: >3,5 g/dia + albumina baixa + edema; lipidemia e lipidúria completam o quadro.

Critérios de síndrome nefrótica

Proteinúria + hipoalbuminemia + edema

Prot >3,5 g/dia + Alb baixa + edema

Adulto: biópsia costuma guiar; criança: LESOES MINIMAS empiricas em cenário típico

Conduta de suporte

- Restrição salina + diurético de alça (cuidado com intravascular efetivo)
- IECA/BRA para reduzir proteinúria se função renal permitir
- Estatina conforme lipidemia; anticoagular se trombose ou risco muito alto (albuminúria grave)
- Vacinas e vigilância de infecção (peritonite espontânea em ascite nefrótica)

Nefrótico × nefrítico

Item | Nefrótico | Nefrítico

Proteinúria | Maciça (>3,5 g/dia) | Leve-moderada

Hematuria | Ausente/leve | Disforma + cilindros

HAS / IRA | Variável | Comuns

Edema | Intenso / anasarca | Presente, menos lipídico

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Risco trombótico (incluindo veia renal) é alto na membranosa e na hipoalbuminemia grave. Dor no flanco + hematúria/ piora de função !' pense trombose de veia renal.